

CST-System

Urogenitaltrakt:

Anamnese:

Jetziges Leiden

1. Lokalisation und Ausstrahlung
2. Qualität
 - brennend
 - juckend
 - + Schmerzen
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
 - Beginn
 - plötzlich - langsam kommend
 - andauernd oder wellenförmig
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
 - Bewegung → Besserung?
 - Miktion
6. Begleitsymptomatik
7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Waren Sie im Ausland (+ ev. Insektenstich)?
- Haben Sie Allergien?
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Lymphknoten
 - Haben Sie Lymphknotenschwellung bemerkt?
- Harntrakt
 - Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen
 - Ist der Urin auffällig, z.B. schaumig oder blutig?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk- oder Muskelbeschwerden
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie?

Sozialanamnese

Welchen Beruf üben Sie aus? (→ Stress)

Körperliche Untersuchung

Inspektion:

- Hautkolorit
 - graubraun bei chron. Niereninsuffizienz
(+ viele andere Inspektionsbefunde)
- Hautturgor
- Atemluft
- Kratzspuren
- Hautblutungen
- Exsikkose/Ödeme
- Behaarung
- Narben
- Anomalien
- Vorwölbung
 - ventral → Nierentumor
 - dorsal → Abzess, Hydronephrose

Palpation:

- auf der Seite beginnen, wo keine Schmerzen vorhanden sind
(Fragen: Wo haben Sie Schmerzen)
- Patient liegt flach auf der Liege
- Organpalpation (normalerweise nicht palpabel):
 - Niere (linke Niere steht höher als rechte Niere)
 - Vergrösserung z.B. Zystennieren oder Nierentumore
 - leichte Palpation bei Anomalien z.B. Senk- oder Wanderniere
(Magersucht, Kachexie)
 - Ureter → 3 Druckpunkte (Ureterengstellen)
 - Harnblase (nur volle Blase ist tastbar):
mit gestreckten Fingern einer Hand kranial der Symphyse auf den Unterbauch tasten
kurzer Druck

Perkussion (→ normalerweise keine Schmerzen)

- Patient sitzt in entspannter Position auf der Liege
- auf der Seite beginnen, wo keine Schmerzen vorhanden sind
(Fragen: Wo haben Sie Schmerzen)
- von dorsal her mit der Faust auf die Nierengegend klopfen
(ev. mit der rechten Faust auf die flache linke Hand klopfen)
- Klopfschmerzhaftigkeit der Niere?
→ Entzündung z.B. Pyelonephritis
- Harnblase → Grössenbestimmung

Auskultation

- Strömungsgeräusch (2cm kranial des Nabels, Rippenregion):
 - Nierenarterienstenosen
 - Nierenarterienaneurysmen
 - Arterio-venöse Shunts
- verminderte oder keine Darmperistaltik
 - Ureterkolik

Haut:

Anamnese:

Jetziges Leiden

8. Lokalisation und Ausstrahlung
9. Qualität
 - brennend
 - juckend
 - + Schmerzen
10. Schweregrad
11. zeitliches Auftreten
12. Verstärkung und Linderung des Symptoms
13. Begleitsymptomatik
 - Schwellung
 - Atemnot
 - Überwärmung
14. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Waren Sie im Ausland (+ ev. Insektenstich)?
- Haben Sie Allergien?
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Lymphknoten
 - Haben Sie Lymphknotenschwellung bemerkt?
- Harntrakt
 - Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen
 - Ist der Urin auffällig, z.B. schaumig oder blutig?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk- oder Muskelbeschwerden?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie?
 - Hauterkrankungen
 - Neurodermitis
 - Allergien

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus? <-> berufliche Exposition

Körperliche Untersuchung:

Haut:

- Hautkolorit:
 - Anämie (HB, Hk unter Normbereich) «Blässe»
 - häufige Ursache: Eisenmangel
 - Nachweis: Nagelbett, Konjunktiven, Mund- und Lippenschleimhaut
 - Zyanose «bläulich»
 - zentral <-> peripher
 - Kapillarpuls (Ohrläppchen -Test)
 - Ikterus «gelblich»
- Gesichtshaut (<-> Alter, Raucher)
- Kopfhaut
- Ohren <-> Knötchen → Gicht
- Xanthelasma (gelblich-verfärbte Auflagerungen)
→ Fettstoffwechselstörungen
- feuchte Hände <-> Nervosität?
- Fettgehalt (Seborrhö <-> Seborrhoe)
- Kratzspuren: Juckreiz=Pruritus
- Veränderungen im Alter:
 - Altersflecken= Lentigo senilis
 - Haut dunkler= Verruca senilis
- Pigmentstörungen:
 - Weissfleckenkrankheit (=Vitiligo)
 - Erworbene, progressive Depigmentierung
 - Albinismus (erblicher Pigmentmangel)
 - Hyperpigmentierung (=Chloasma uterinum)
 - v.a. im Gesichtsbereich
 - während der SWS oder Pilleneinnahme
 - sekundär erworbene Depigmentierung
 - nach Abheilung chron. entzündl. Prozesse
- Effloreszenzen

primär (erste, sichtbare & tastbare Veränderungen)	sekundär unter dem Hautniveau:
■ Pustel (=Pustula)	■ Erosio (ob. Schürfung)
■ Bläschen (=Vesicula)	■ Excoratio (tiefe Schürfung)
■ Knoten (=Nodus)	■ Einriss (=Fissur)
■ Papel (=Papula)	■ tiefer Defekt (=Ulkus)
■ Quaddel (=Urtika)	■ Narbe (=Cicatrix)
■ Fleck (=Makula)	über dem Hautniveau:
	■ Schuppe (Squama)
	■ Sekretkruste (=Crusta)

Haare:

- Beschaffenheit
- Haarfülle
- Haarausfall
 - temporär (Medikamente, nach der Geburt) oder permanent (Hormone, Hauterkrankungen)
 - Haarausfallmuster
 - Geschlechter-spezifisch:
M: Androgen-abhängig (95%)
vgl. F: v.a. im Scheitelbereich
 - ! kreisrunder Haarausfall: Alopecia areata
- Haarwachstum↑ : v.a. bei Medikamentennebenwirkungen

Nägel: Farbe, Flecken oder brüchig?

Schweissproduktion (Wärmeregulation, Säureschutzmantel):

- gesteigert (=Hyperhidrosis) <-> gering (=Oligohidrosis) oder keine (=Anhidrosis)
- unangenehm riechend (=Bromhidrosis)

Entzündungszeichen: Schwellung (=Tumor), Funktionseinbusse (=Functio laesa), Rötung (=Rubor), Juckreiz und Schmerz (=Dolor), Überwärmung (=Calor)

Schilddrüse:

Anamnese

Jetziges Leiden

1. Lokalisation und Ausstrahlung
2. Qualität
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
6. Begleitsymptomatik

Hyperthyreose (↑- Stoffwechselaktivität)	Hypothyreose (↓- Stoffwechselaktivität)
○ Gewichtsabnahme ○ Heisshunger ○ warm → Schwitzen ○ hoher BD ○ Müdigkeit	○ Gewichtszunahme ○ Appetitlosigkeit ○ kalt → Frieren ○ niedriger BD ○ Müdigkeit

7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Waren Sie im Ausland (+ ev. Insektenstich)?
- Haben Sie Allergien?
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Lymphknoten
 - Haben Sie Lymphknotenschwellung bemerkt?
- Herz-Kreislauf
 - Spüren Sie Ihr Herz?
 - Haben Sie ein Enge- und Druckgefühl am Herzen?
- Harntrakt
 - Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen
 - Ist der Urin auffällig, z.B. schaumig oder blutig?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk- oder Muskelbeschwerden?
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie?
 - Hyperthyreose oder Hypothyreose
 - Depressionen (<-> Schilddrüsenerkrankungen)

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus? (→ Stress)

Körperliche Untersuchung

Inspektion:

- Sieht der Patient müde aus?
- feuchte, zittrige Hände (oft bei Hyperthyreose)
- Augen
 - in gleicher Augenhöhe mit dem Patienten
 - Äussere Augenabschnitte
 - Lidbeschaffenheit (Schwellung, Rötung, Schuppen, Ulzera)
 - Lidspaltenweite
 - Häufigkeit des Lidschlages (norm.: alle 2-3 sec.)
 - ! seltener Lidschlag bei Morbus Basedow
 - !Exophthalmus
 - einseitig: Tumor, vaskulär, Entzündung
 - beidseitig: vaskulär
- Schilddrüsenvergrösserung (Struma) von aussen sichtbar?

Palpation:

- normal nicht tastbar → sonst Struma
- Patient sitzt auf dem Stuhl und neigt den Kopf zurück
<-> Arzt steht hinter dem Patienten und tastet den Bereich der Schilddrüse bimanuell
+ Patienten ev. Wasser geben → schlucken
→ falls Schilddrüse mit Larynx nach kranial bewegt = Struma

Auskultation:

- Strömungsgeräusche über der Schilddrüsengegend

➔ **Struma= jede tast- o. sichtbare Schilddrüsenvergrösserung kann sowohl bei Hyper- als auch Hypothyreose vorkommen**

Lymphknoten:

Anamnese:

Jetziges Leiden

1. Lokalisation und Ausstrahlung
2. Qualität
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
6. Begleitsymptomatik
 - mit oder ohne Schmerzen
 - Schwellung
 - Atemnot
 - Überwärmung
7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Waren Sie im Ausland (+ ev. Insektenstich)?
- Haben Sie Allergien?
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Lymphknoten
 - Haben Sie Lymphknotenschwellung bemerkt?
- Harntrakt
 - Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen
 - Ist der Urin auffällig, z.B. schaumig oder blutig?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk- oder Muskelbeschwerden?
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie z.B. Erbkrankheiten ?

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus? (berufliche Exposition)

Körperliche Untersuchung:

Inspektion (vgl. Erkrankungen):

Lymphangitis	offene Wunde <-> Keime, roter Streifen
«extreme» Lymphknotenpakete	maligne Lymphome chron. Lymphatische Leukämie
Tonsillitis	Lokale Lymphknotenschwellung
eiternde Lymphknoten	Tuberkulose usw.

Palpation:

- Welche sollte man palpieren?
 - vor und hinter dem M. sternocleidomastoideus
 - im Kieferwinkel
 - axillär
 - am Oberarm medial oberhalb der Ellenbeuge
 - retroaurikulär und präaurikulär
 - supraklavikulär
 - seitlich am Thorax
 - Inguinal (an der Leiste)
- ! Lymphknotenschwellungen
 - häufig
 - Junge Patienten: v.a. bei entzündlichen Erkrankungen
 - <-> ältere Patienten: v.a. tumorösen Ursprungs
- Untersuchung
 - Patient in entspannter Position
 - <-> Arzt: Palpation mit den Fingerspitzen
 - Schwellung? → zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen fassen und bewegen
 - jeder tastbare Lymphknoten ist vergrössert
 - Beurteilungskriterien:
 - Lokalisation
 - Anzahl
 - Grösse (cm)
 - Konsistenz
(weich, derb, fest, hart, holzig oder fluktuierend)
 - Verschieblichkeit
 - Druckschmerzhaftigkeit
(indolent, schwach → stark)
➔ bsp.: akut → weich, dolent
vgl. chronisch → hart, indolent

Venöse Durchblutungsstörungen:

Anamnese:

Jetziges Leiden

1. Lokalisation und Ausstrahlung
2. Qualität
 - Schwere- und Stauungsgefühl
 - + Schmerzen
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
 - Ruhe und Bewegung
6. Begleitsymptomatik
 - Schwellung
 - Atemnot
7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Waren Sie im Ausland (+ ev. Insektenstich)?
- Haben Sie Allergien?
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Lymphknoten
 - Haben Sie Lymphknotenschwellung bemerkt?
- Harntrakt
 - Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen
 - Ist der Urin auffällig, z.B. schaumig oder blutig?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk-oder Muskelbeschwerden?
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie?

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus? <-> berufliche Exposition

Körperliche Untersuchung:

Inspektion:

- Fortgeschrittene Insuffizienz des Venensystems → Hautschäden
→ Verhärtung, Atrophie, Verfärbung, Ödeme und Ulzerationen (nie an den Zehen)
- Venenwand-Schwäche → Krampfaden (=Varizen)
- Thrombophlebitis (=Venenentzündung) → gerötete-verhärteter Venenstrang
- Tiefe Beinvenen → Kollateralvenen

Palpation:

- Umfangsdifferenzen → Beinvenenthrombosen
- Payr-Druckpunkt → Unterschenkelthrombosen
- Verhärtung – Konsistenz → Thrombose
- Homans – Zeichen →
- Druckschmerz → Thrombophlebitis

Funktionstests:

- Trendelenburg -Test
 - = klein. Diagnose insuffizienter Venenklappen der:
 - V. saphena magna und -parva
 - Vv. Perforantes
 - Vorgehensweise:
 1. Patient: Stauung angelegt, liegen
 2. Arzt: Varizen anstreichen
 3. Patient: steht auf und nach 30 sec. wird die Stauung geöffnet

normal: langsame Wiederauffüllung der epifaszialen Stammvenen von distal nach proximal

pathologisch: sehr langsame Wiederauffüllung → Insuffizienz

- Perthes – Versuch
 - = Überprüfung der Venenklappen supfaszialer Leit- und transfaszialer Perforansvenen
 - Vorgehensweise:
 - Patient: Stauung bis zum Knie anlegen, stehen
 - ca. 5min. umherlaufen
 - Venen werden ohne Öffnung der Kompression beurteilt

normal: Entleerung

pathologisch: keine Entleerung → Insuffizienz, + Schmerzen → tiefe Venen betroffen

Ödeme:

(Lymphödem, Lipidödem, Myxödem, Venenthrombose usw.)

Inspektion:

- Vergleich beider Beine
 - einseitig: Lymphödem, Venenthrombose
 - beidseitig: Rechtsherzinsuffizienz
- Zehen betroffen?
 - nein: kardiale, renale und venöse Ödemen
 - <-> ja: Lymphödem

Palpation:

- Vorgehensweise: vorsichtiges, langsames Wegdrücken der Ödemflüssigkeit durch die Daumenkuppen (ca. 4-5 sec.)
- sichtbare Eindellung?
(beim Lymphödem nicht wegdrückbar, da eher hart)
- Stemmer – Zeichen (Hautfalte über Grundphalanx nicht abhebbar) → Lymphödem

CST - Lunge

Anamnese:

Jetziges Leiden (meist Dyspnoe, Husten und Schmerzen)

1. Lokalisation (obere oder untere Atemwege) und Ausstrahlung
2. Qualität bei
 - Atemnot(=Dyspnoe): Wie viele Stufen, Treppen können Sie ohne Luftnot steigen?
 - Husten: mit oder ohne Auswurf? (Sputum: Farbe, Menge)
 - Schmerzen: dumpf oder stechend
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
 - lang (akut vgl. chronisch) oder plötzlich
 - andauernd oder kommt und geht weg
 - nächtliche Atemnotanfälle
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
 - Belastung (z.B. Sport) vgl. Ruhe
 - Kälte
 - Lippenbremse
 - nimmt die Luftnot im Liegen zu oder bessert sie sich bei aufrechtem Sitzen mit aufgestütztem Thorax (Orthopnoe)?
6. Begleitsymptomatik (nach denen Fragen, die der Patient noch nicht erwähnt hat)
 - Dyspnoe, Husten, Schmerzen
7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle (allg. Unfall <-> Pneumothorax)?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?
 - Waren Sie im Ausland? (<-> Tuberkulose)

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien? (z. B. Acetylsalicylsäure → Asthma)

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Thorax und Brust
 - Haben Sie Herzbeschwerden? Spüren Sie Ihr Herz?
- Harntrakt
 - Wie oft müssen Sie Wasserlassen?
 - Haben Sie Schmerzen dabei?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk- oder Muskelschmerzen?
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie?
 - z.B. Asthma, Allergien + andere Herz- oder Lungenerkrankungen

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?
 - ! medizinisch relevante Exposition (Asbest) und Stressfaktoren

Inspektion:

- Thoraxform
- Atemfrequenz und -tiefe
 - Normale Atemfrequenz: 12-16/min
- Atemtypus
 - Verhältnis Inspiration zu Expiration
 - Atemhilfsmuskulatur
 - Lippenbremse
- Zyanose
- Ödeme
- Lymphknotenvergrößerungen

Auskultation:

- zu beachten:
Patient sitzt mir vorgebeugtem Oberkörper und atmet tief durch den geöffneten Mund
➔ Vorgehensweise:
von oben nach unten auskultieren
auf Inspirations- & Expirationsgeräusche achten
Seitenvergleich
- Geräusche
 - Atemgeräusche
 - normal:
 - über Lungenflügel (peripheres AG)
 - über der Trachea (zentral AG)- rauher = Bronchialatmen
 - abnormale Atemgeräusche:
(abgeschwächtes AG; Bronchialatmen)
 - Bronchialatmen über Lungenperipherie
 - (Stridor in oberer Trachea oder den Stimmlippen; Pleurareiben ist lokalisiert)
 - Nebengeräusche:
 - Kontinuierliche Nebengeräusche
 - Giemen (hochfrequent)
 - Pfeifen (hochfrequent)
 - Brummen (tieffrequent)
 - Diskontinuierliche Nebengeräusche:
 - zentrale = grobe Rasselgeräusche
 - periphere = feine Rasselgeräusche

Palpation:

- Stimmfremitus
 - normal: hörbar
 - pathologisch:
 - Verstärkung: Pneumonie
 - Abschwächung: Atelektase, Pleuraerguss, Pneumothorax, Emphysem, Asthma bronchiale
- Bronchophonie
 - normal: hört nichts über das Stethoskop
 - pathologisch: hochfrequentes Geräusch
 - pneumonische Infiltrate
 - Atelektase
- + Lymphknoten am Hals und ev. axillär

Perkussion:

- zu beachten:
Patient sitzt mir vorgebeugtem Oberkörper
➔ Vorgehensweise:
von oben nach unten perkutieren
Seitenvergleich
- Lungengrenzen bestimmen
 - normale Atmung & bei Ein- und Ausatmung
- Schallqualitäten
 - normal = sonor
 - hypersonor, Dämpfung....

Asthma bronchiale	COPD
Kinder und Jugendliche	Alter
kein Zsmhg.	oft, direkter Zsmhg.
anfallsartig	bei Belastung
variabel	progredient
häufig	selten
ja	nein
funktionelle Veränderungen zentrale Atemwege betroffen	strukturelle Veränderungen periphere Atemwege betroffen

- **Infektionskrankheiten**
Dyspnoe, Fieber, oft Husten, bei Pneumonie oft grün-gelbliches Sputum
- **Bronchuskarzinom**
oft unspezifisch, Husten, Dyspnoe, Gewichtsverlust, Hämoptysse, Thoraxschmerzen, Heiserkeit, Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Risikofaktoren
- **Interstitielle Pneumopathie**
Anstrengungsdyspnoe, Niedervolumige-hochfrequente Ruheatmung, feine Rasselgeräusche
- **Pneumonie**
Stimmfremitus verstärkt + Bronchophonie, Perkussion (Dämpfung), Bronchialatmen, feine Rasselgeräusche
- **Pleuraerguss**
Stimmfremitus vermindert, Perkussion (Dämpfung), abgeschwächtes AG + ev. Pleurareiben
- **Pleuritis**
Trockene Pleuritis: «Lederkanerren» bei der Auskultation
- **Pneumothorax**
=Luft im Raum zwischen den Pleurablättern ➔ Kollaps der Lunge
Spontanpneumothorax:
 - betroffen sind v.a. junge, schlange grosse Männer
 - Symptome:
 - Plötzlicher Thoraxschmerz
 - Atemnot
 - Trockener Husten
 - Diagnose:
 - Auskultation: kein Atemgeräusch
 - Perkussion: hypersonorer Klopfeschall
 - Ursachen:
 - Thoraxtrauma
 - Lungen- oder Bronchialerkrankungen
- **!! Spannungspneumothorax**
+ Luft inspiratorisch und kann expiratorisch nicht weg ➔ Luftansammlung

CST – Herz - Kreislauf

Anamnese:

Jetziges Leiden

1. Lokalisation und Ausstrahlung
2. Qualität
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
6. Begleitsymptomatik
 - Dyspnoe
 - Synkopen: « aus heiterem Himmel »
 - Durst (Schwindel, Kopfschmerzen usw.)
 - nachts Wasserlassen (=Nykturie)
 - Ödeme
 - Gewichtszunahme (Aszites)
 - Zyanose
 - Leistungsminderung
7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Allergien
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?
 - Erhöhtes Cholesterin?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?
-> Acetylsalicylsäure (v.a. Aspirin)?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome (immer fragen)
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant?
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Lunge
 - Haben Sie Atemnot?
 - Müssen Sie oft husten?
- Harntrakt (nachts Wasserlassen, ev. Schmerzen)?
- Gelenke und Muskeln
 - Haben Sie Gelenk- und Muskelbeschwerden?
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie, z.B. Herzinfarkt (in welchem Alter)?

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus? -> Stressfaktoren

Krankheiten:

- **Angina Pectoris:**
Retrosternal -> Ausstrahlung in den linken Arm
stechend, Enge- und Druckgefühl
stabil: kurz & in Ruhe weg vgl. instabil: lang & auch in Ruhe
Verstärkung: Anstrengung, Kälte
Linderung: Ruhe, Nitratversuch
- **Funktionelle Herzbeschwerden**
punktuell, an Herzspitze
brennend- stechend, «Herzjagen und – stolpern» beschrieben
lange, auch in Ruhe
Verstärkung: Stress
Linderung: sich beruhigen
- **Gefässerkrankung (pAVK: «Schaufensterkrankheit»)**
v.a. am Unterschenkel (weisses Bein)
Schwere- und Stauungsgefühl
Lang -> Arteriosklerose, plötzlich -> Embolie
Verstärkung: Bewegung
Linderung: Ruhe
- **Rechtsherz- & Linksherzinsuffizienz**
Wichtige Fragen:
 - Können Sie flach schlafen?
 - Wie viele Kopfkissen brauchen Sie?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
 - Müssen Sie aufstehen, weil sie keine Luft mehr bekommen? Was machen Sie dann? Öffnen Sie z.B. das Fenster? Besserung?
 - Schwellen Ihre Beine abends an? Sind die Schwellungen am Morgen wieder weg?
 - Haben Sie husten? Trocken oder mit Auswurf (Sputum: Farbe, Menge)?

Rechtsherzinsuffizienz	Linksherzinsuffizienz
○ Beinödeme -> wärmer, dunkler ○ obere Einflusstauung ○ Aszites ○ Nykturie	○ Lungenödem ○ Dyspnoe/ Orthopnoe ○ Husten ○ Extremitäten kalt und blass (ev. zyanotisch)
➔ Müdigkeit und Gewichtszunahme	

Herz:

Palpation Herzspitzenstoss

Auskultation

(in Ruhe, Atemruhelage, + Pulsmessung radial)

- Wo auskultieren:
 - 1. Herzton (leiser) über Segelklappen
 - Mitralklappe: 5. ICR l. (Linksseitenlage)
 - Trikuspidalklappe: 4. ICR r.
 - 2. Herzton (lauter) über Taschenklappen
 - Aortenklappe: 2. ICR r. (auch vorbeugend)
 - Pulmonalklappe: 2. ICR r.
 - + Erb'scher Punkt: 3. ICR r.
- Auswertung
 - Punctum maximum
 - Lautstärke: 1/6 (leise) – 6/6 (laut)
 - Klangcharakter
 - zeit. Zuordnung und Verlauf: Systole - Diastole kontinuierlich oder crescendo-decrescendo

Peripheres Gefässsystem:

Inspektion:

- Abnorme Füllung
- Pulsation
- ! obere Einflusstauung (Halsvenen anschauen, 45-Winkel)
→ Rechtsherzinsuffizienz

Palpation:

- Karotis
 - Beurteilung des Pulsdefizits
 - Medial des M. sternocleidomastoideus tasten (EINSEITIG, mit geringem Druck)
! → hypersensitiver Karotissinus: Bradykardie mit Herzstillstand & Synkope
(+ ev. zerebrale Durchblutungsstörung)
- Temperatur der Extremitäten

Auskultation

- Stethoskop nur leicht ohne Druck auf Karotis
- Stenosegeräusch – Lautstärke:
→ hängt nicht vom Schweregrad ab

Pulsmessung

- Vorgehensweise:
Mit der sicheren Hand (Zeige- und Mittelfinger)
15 sec. x 4 lang messen
- Pulsquantität (Frequenz, ca. 60/min)
- Pulsqualität (Regelmässigkeit):
 - regelmässig
 - nicht regelmässig
 - respiratorisch: unt. Ein- und Ausatmung
 - «echte» Arrhythmie:
 - Extrasystole
Regelmässigkeit in der Unregelmässigkeit
 - Vorhofflimmern
«schwerwiegender» Befund
Herzinsuffizienz
Pulsintervalle unterschiedlich
→ ABSOLUTE Arrhythmie

Welche Arterien?

- A. carotis (einseitig!)
- A. axillaris
- A. brachialis
- A. radialis und ulnaris
- A. poplitea
- A. tibialis posterior
- A. dorsalis pedis

Blutdruckmessung

- zu beachten:
 - ruhige, entspannte Position (Liegen oder Sitzen)
 - richtige Manschettengrösse
 - zu gross: falsch niedrige Werte
 - zu klein: falsch hohe Werte
 - Puls palpation
 - ruhige Armlage in Herzhöhe
 - Ablassgeschwindigkeit (3-5mmHg/sec.)
 - richtiges und genaues Ablesen der Werte
- Vorgehensweise
 - Sitzen oder Liegen
 - Unterarm entspannt und in Herzhöhe
 - Manschette am Oberarm eng anliegen, Innenseite
 - A. brachialis tasten
 - Stethoskop auf die A. brachialis
 - Manschette aufpumpen bis kein Puls mehr hörbar ist + 20mmHg
 - Manschetendruck langsam ablassen
→ Korotkow-Geräusche: systolischer Blutdruck
→ nichts mehr hörbar: diastolischer Blutdruck
- Beurteilung der Werte
 - optimal-«noch normal»: 120-139 S, 80 - 89 D
 - leichte – schwere Hypertonie: 140-180 S, 90 -110 D
 - systolische Hypertonie: > 140 S, < 90 D
- Hypertonie
 - Hypertensive Krise → plötzliche ++BD
 - maligne Hypertonie → + Verschlechterung herz-, nieren- oder zerebraler Funktion
 - primäre Hypertonie
 - familiäre Anlage
 - Übergewicht
 - Bewegungsmangel
 - Stress
 - salzreiche Ernährung
 - <-> sekundäre Hypertonie (hormonelle Störung, Nierenerkrankung)
 - Blutdruck <-> zirkadianer Verlauf
 - Grosse Blutdruckamplitude (v.a. im Alter)
 - > 160mmHg S
 - < 90mmHg D
- ABI (norm ca. 0,9 -1)
 - Vergleich der BD am Fussgelenk und Arm
 - liegend messen

CST - Abdomen

Anamnese:

Jetziges Leiden

1. Lokalisation und Ausstrahlung:
(funktionell <-> organisch, somatisch <-> viszeral)
2. Qualität (dumpf <-> stechend, brennend)
3. Schweregrad
4. zeitliches Auftreten
 - Schmerzbeginn und-dauer
 - Häufigkeit und Periodik
5. Verstärkung und Linderung des Symptoms
 - Nahrungsaufnahme
 - Stuhlgang
 - Erbrechen
 - Miktion
 - Körperlage und-haltung
6. Begleitsymptomatik
 - Übelkeit
 - Erbrechen
 - Durchfall oder Verstopfung (Stuhlaussehen?)
 - Bauchschmerzen
7. Grad der Behinderung

Persönliche Anamnese

- Haben Sie chronische Erkrankungen?
- Frühere Erkrankungen/Unfälle?
- Hospitalisationen/ Operationen?
- Allergien
- Risikofaktoren
 - Rauchen Sie?
 - Trinken Sie regelmässig Alkohol?
 - Haben Sie Diabetes?
 - Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?

Medikamentenanamnese

- Nehmen Sie Medikamente ein?
- Welche, wie heissen sie?
- Wie lange? Regelmässig oder bei Bedarf?
- Medikamentenallergien?
- ev. nach Einnahme von Abführmitteln fragen?

Systemanamnese (problemorientiert)

- Allgemeinsymptome
 - Wie ist Ihr Appetit, Ihr Durst?
 - Ist Ihr Gewicht konstant? (Zunahme: Aszites)
 - Haben Sie Schlafprobleme
 - Schwitzen Sie nachts?
 - Haben Sie gelegentlich Fieber oder Schüttelfrost?
- Harntrakt
 - Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen?
 - Ist der Urin auffällig?
 - Müssen Sie nachts raus zum Wasserlassen?
- Haut
 - Haben Sie Hautveränderungen bemerkt?

Familienanamnese

- Gibt es irgendwelche Gesundheitsprobleme in Ihrer Familie, z.B. Erbkrankheiten?

Sozialanamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus? <-> Stress

Krankheiten

- **Peritonitis**
«akutes Abdomen»
Notfall!
ganze Bauchregion
andauernd
Linderung: nicht bewegen, liegen
- **Appendizitis**
rechter Unterbauch
andauernd?
ev. → Peritonitis
- **Nieren- und Ureterkoliken**
Flanken, Leiste usw.
auf- und ab
Linderung: Bewegung
Unterscheidet sich im Stärkegrad
- **Pankreatitis**
Nabelbereich
Linderung: Zusammenkauern
- **Cholezystitis und Gallensteinkoliken**
rechter Oberbauch
Linderung: Zusammenkauern
Hautkolorit beachten

zu beachten:

- ➔ Der Patient sollte entspannt auf der Liege liegen
- ➔ Wichtige Frage vor der Untersuchung:
 - Wo haben Sie Schmerzen?
 - ! WEG vom Schmerz

Inspektion:

- Hautkolorit? ➔ !-gelb (<-> Ikterus)
 - = Gelbfärbung von Geweben und Körperflüssigkeiten durch eine erhöhte Bilirubinkonzentration
 - Sichtbar ist v.a. der «Sklerenikterus»
 - Färbung <-> Lokalisation
 - blassgelb: prähepatisch, z.B. Hämolyse, Thalassämie oder toxische Ursachen
 - gelbrot: hepatisch, z.B. Hepatitis, Zirrhose
 - grüngelb: posthepatisch, z.B. Verschluss des Gallengangs
- Narben <-> OP's?
- Vorwölbungen
 - Hernien
 - Leisten- und Schenkelhernien
 - Rückgängig beim Liegen ➔ Patient sollte auch Stehen
 - Tumore (holzartig-hart)
- Striae (Streifen) (<-> SWS, Morbus Cushing)
- Gefäßzeichnungen (! «Caput medusae»)
- Behaarung (! «Bauchglatze» beim Mann)
- sichtbare Peristaltik
- Pulsationen

Auskultation:

- Normale Darmgeräusche
- ! keine Geräusche <-> «Grabstille» = paralytischer Ileus
- Abdominelle Gefäße
- ev. Kratzauskultation der Leber
 - Stethoskop am Proc. xyphoideus
 - von oben nach unten kratzen

Palpation:

- dort beginnen, wo keine Schmerzen angegeben werden
- Rüttelschmerz
- Klopfschmerzen
- Jeden Quadranten oberflächlich und tief mit beiden Händen palpieren
- den Patienten dabei beobachten ➔ Gesichtsausdruck
- ! unwillkürliche Abwehrspannung
 - Entzündung
 - «akutes Abdomen»
- Loslassschmerz (auf der gleichen Seite und gekreuzt)
 - ca. 30 sec. eindrücken
 - plötzlich loslassen
 - ! Schmerzen beim Loslassen: PERITONITISCHES Zeichen
- Psoaszeichen
 - Rechtes Knie des Patienten auf die Unterlage drücken und Patient sollte das Bein anziehen
- Obturationstest
 - Das rechte Hüft- und Kniegelenk + Bein in der Hüfte einrotieren
 - ! Appendizitis
- McBurney- und Lanz Punkt bei Appendizitis tasten

○ Organpalpation

- Leber
 - Gleitpalpation
 - kaum tastbar (! Lebervergrößerung)
- Gallenblase
 - normalerweise nicht tastbar
- Milz
 - ! palpable Milz ist immer pathologisch
 - Splenomegalie ➔ Blutungen (durch Thromozytopenie)
- Pankreas
 - normales Pankreas ist nicht tastbar
 - ! Pankreatitis: Druckschmerz
- Dünn- und Dickdarm
 - normalerweise nicht tastbar
- Aorta abdominalis
 - ! Aortenaneurysm v.a. bei älteren Patienten ➔ geschlängelter Verlauf

Perkussion

- Lebergrenzen bestimmen

Aszites:

- Beschwerden
 - Vergrößerung des Leibesumfanges
 - Gewichtszunahme
- Ursachen
 - v.a. chronische Lebererkrankungen (bei über 80%)
 - maligne Erkrankung
 - Herzinsuffizienz
 - Tuberkulose
 - Nephrotisches Syndrom
- Untersuchung
 - kleine Aszitesmengen
 - Patient in Knie-Ellenbogen-Lage
 - Dämpfung sam tiefsten Punkt in der Nabelgegend (in Rückenlage weg)
 - grössere Aszitesmengen
 - Undulationsphänomen
 - Eine Hand auf die Flanken legen und mit der anderen klopfen
➔ Anschlagen der Flüssigkeitswelle
➔ ASZITES

Rektaluntersuchung (sagen, dass man es machen wird nach normaler Abdomenuntersuchung):

- Vorgehensweise:
 1. den Patienten bitten sich in die geeignete Stelle zu positionieren (der Patient liegt linksseitig, Rücken zum Arzt)
 2. sagen, was man machen wird
 3. mit dem Rücken zum Patienten/Patientin
 4. Handschuhe anziehen
 5. rechte Hand ins Rektum
- Auf was sollte man achten
 - M: Prostataveränderungen (ventral vom Rektum)
 - F: irgendwelche Veränderungen am Uterus (ventral vom Rektum)